



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : اسماء سيد محمود خليل
المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : قلوب
رقم البطاقة : 28207101403628 رقم التليفون : 01060162659
العنوان : 44
العمر (تاريخ الميلاد) : 10-07-1982 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: اسماء سيد محمود خليا National ID: 28207101403628	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

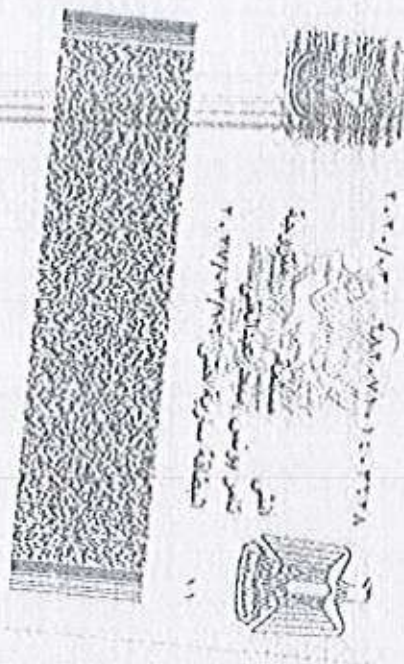
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Name: اسماء سيد محمود خليل		
MR. : 4387		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
	رقم طبي:	بقسم:
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها The patient was prescribed Femara (letrozole) and magnesium calcium 1 × 1 × 90 tablets, along with One Alpha and Zoladex 10.8 mg, in preparation for a bone scan following a recent left arm fracture documented in March 2026. A subsequent bone scan performed in May 2026 demonstrated no evidence of metastatic disease. The patient was noted to be free of disease on the scan performed in April 2026 and was continued on Femara for an additional three months.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	18-09-2026
	الوقت :	ايه مدحت بدوي محمد
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Patient Name : الأمتلاء / اسماء محمد محمود جبار	Request No. : 13000711
Patient No. : 28207101403628	Request Date : 16/10/2022
Path No. : 3058/22	Verification Date : 05/11/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - لوزام دار السلام
Age : 40 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer (post NACT) .

Nature of the specimen: Right MRM

Gross Examination:

- Procedure: Right MRM
- measured 17x16x10 cm with covering skin ellipse measured 16x12cm & attached axilla 9x5 cm .
- Tumor extent : soft well circumscribed mass and greyish white tumour bed site
- Size: mass 1,5 x1,5 x1cm and tumor bed site 6x6x4 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 2 cm away from deep margin.
- Lymph nodes number and size: 10 L.Ns up to 1.5x1 cm .

Microscopic examination:

- Histological type: No residual viable tumor tissue detected
- Ductal carcinoma in situ: No
- Additional findings: Surrounding breast tissue showing fibrodenoma and focal sclerosing adenosis.
- Skin involvement: Free nipple and areola.
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/10)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic Complete response

Diagnosis:

Right MRM (post NACT) :

No residual viable tumor tissue.

- Pathologic Complete Response
- Fibrodenoma and focal sclerosing adenosis.
- Free margins
- Free nipple and areola

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud



وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية

القصر العام

وحدة تشخيص أمراض الدم

قسم الباثولوجي

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Name: اسماء عبد محمود

Pathology Number: 6211 - 2022

Age: 39 Y

Patient's ID: 28207101403628

Date: 28/03/2022

HISTORICAL DATA: A case of right breast cancer, for estrogen, progesterone receptors, Her-2/neu and Ki-67.

PROCEDURE: Sections from paraffin block were treated with antigen retrieval solution and then treated with monoclonal antibodies for estrogen, progesterone, Her-2/neu and Ki-67 (CONFIRM™ anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit & CONFIRM™ anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2) & CONFIRM™ anti-HER-2/neu (4B5) Primary Antibody), CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Primary Antibody), using Ventana iView™ system. DAB was used as a chromogen and hematoxylin as a counter stain.

RESULTS:

- Examination of section treated for estrogen receptors revealed moderate positive nuclear staining in 20% of tumor cells by chromogen.
- Examination of section treated for progesterone receptors revealed moderate positive nuclear staining in most of tumor cells by chromogen.
- Examination of section treated for Her-2/neu revealed strong positive membrane staining in most cells by chromogen (score 3+).
- Examination of section treated for Ki67 revealed positive nuclear stain in average of 70 % of tumor cells.

CONCLUSION:

Tumor Cells showed:

- Positive Estrogen Receptors Score 6/8.
- Positive Progesterone Receptors Score 7/8.
- Positive Her-2/neu Over-Expression (Score 3+).
- 70% Ki-67 Proliferation Index.

NOTE: All controls show appropriate reaction.

DR. DR. AHMED ABDEL AZIZ

DR. SAMIA GABAL

1/2/21
1/2/21



Patient Name: Asmaa Sayed Mahmoud Khali	Date: 05/07/2022
Exam: TRIPHASIC ABDOMEN & PELVIS	Age: 40 Year(s)

**MULTI-SLICE CT SCAN OF THE ABDOMEN AFTER I.V.
CONTRAST ADMINISTRATION WITH TRIPHASIC LIVER
STUDY:-**

*****Known case of right breast cancer.***

Findings:

- A well-defined cystic lesion with peripheral curvilinear calcifications is seen related to the right posterior abdominal wall and indenting but separable from the posterior part of right hepatic lobe and right kidney. It shows no significant enhancement on different phases, measuring about 6 x 5 X 5.3 cm at its maximal dimensions.
- The liver is enlarged size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicle dilatation.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the spleen, pancreas, aorta, I.V.C and both supra renals.
- No abdominal lymph node enlargement seen.
- No ascites nor abdominal collections noted.
- scanned lung bases showing bilateral atelectatic bands.

Opinion:

- Hepato-renal cystic lesion with peripheral calcifications likely old infection sequel.
- No CT evidence of metastatic hepatic deposits.

Dr. Ayat Nadi

Dr. Amir Eddouk, M.D.



الجمهورية العربية السورية
مجلس الباثولوجيا
جامعة القاهرة

PATHOLOGY REPORT

Name: اسماء محمد محمود

Pathology Number: 621 - 2022

Age: 39 Y

Patient's I.D: 28207101403628

Date: 02/03/2022

CLINICAL DATA: Right breast lesion

NATURE OF THE SPECIMEN: US guided core biopsy

GROSS EXAMINATION: Multiple cores, totally submitted.

HISTOSCOPIC EXAMINATION: Serial sections examined revealed multiple tissue cores infiltrated by a malignant growth composed of nests and sheets of malignant ductal epithelial cells showing moderate degree of pleasia, surrounded by mildly desmoplastic stroma.

DIAGNOSIS: Right Breast Lesion, US Guided Core Biopsy:

Invasive Duct Carcinoma (NST), GII

DR. AHMED ABDEL AZIZ

DR. SOMIA ABDEL LATIF